<2020 본 3 학년말고사 - 외과>

15,16 년도 시험에서까지 야마를 탔습니다..

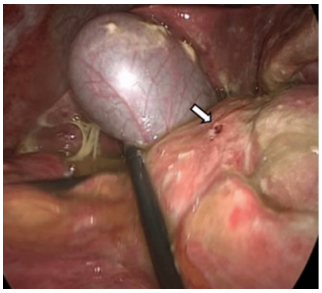
1. 유방암 조기진단 선별검사는?

① 컴퓨터 유방촬영술
② 유방촬영술
③ 자기공명유방촬영술
④ 유방초음파

2. (Y) 70 세 여자가 혈변과 뒤무직으로 외래에 내원하였고 직장수지검사에서 항문연 4cm 위로 단단하고 뒤로 밀리지 않는 덩어리가 만져졌다. 대장내시경 검사결과 선암으로 진단되었고 그 외에 용종은 발견되지 않았다. ct 상에 직장주변에 림프절 커진 소견만 있고 mri 상으로 직장벽을 침범하지 않은 소견을 나타내고 그 외에는 없었다. CCRT 후 초저위전방절제술을 할 계획인데 수술 때 반드시 같이 해야 하는 것은?

① 일시적 장루형성술
② 전 직장간막 절제술
③ 충수돌기절제술
④ J 형 낭형성술
⑤ 측부 골반림프절제거술

3. (Y) 50 대 남자가 복통 호소하며 옴, 복부강직 있었고 x ray 상 횡격막 아래 공기음영 있었다. 사진 참고할 때 해야 할 것은?



① Primary closure
② Distal gasterectomy
③ Distal gasterectomy + D2 lymphadenectomy
④ Antrectomy+vagotomy

4. (Y) 다음 기구 어디에 쓰나?



① resection & anastomosis
② retraction & anastomosis
③ retraction & suction
④ suction & irrigation
⑤ resection & irrigation

5. (Y) 11 세 여자가 계단에서 구른 이후로 우상복부 통증을 호소하였다. 복부압통이 있었으나 반발압통은 없었다. BP 100/80, Hb 11.2 어떤 처치를 해야 하는가?
(사진은 약간 달랐습니다.)



① 경과관찰
② 진단적 복강세척
③ 진단적 개복
④ 배액관 삽입
⑤ 혈관조영술

6.(Y) 위 GIST 로 추정(문제에 **위 기질 종양**이라고 언급)되는 종양으로 복강경 사진 줌 (위 경계 밖으로 mass 가 돌출되어 있고 Omentum 과 유착되어있는 양상) 처치는?

① 쐐기절제술 + 광범위 림프절 절제

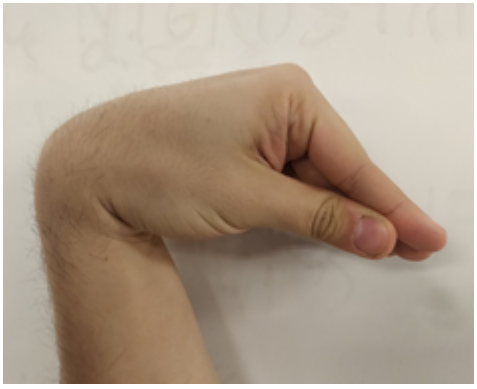
② 쐐기절제술 + 주변 림프절 절제

③ 쐐기절제술

④ 위 원위부 절제 + 광범위 림프절 절제

⑤ 위 원위부 절제

7. (Y) 갑상선 전절제술을 받은 환자. 수술 다음날 온몸이 저리고 손발 끝이 수축하는 양상. 옳은 조치는?



① IV 칼슘 투여 후 칼슘 농도 측정

② 갑상선 호르몬 측정하여 얼마나 저하되어 있는지 파악

③ 일시적인 현상으로 환자 안심시킨다.

④ 수술과정 중 잘못된 자세로 신경이 눌려 생긴 현상이다.

⑤ EMG 실시.

8. 유방초음파가 유방촬영술(mammography)에 비해 장점으로 옳지 않은 것은?

① 유방촬영술로 애매한 병변에 도움이될 수 있다.

② 낭종을 확인하는데 유용하다.

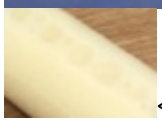
③ 미세석회화를 보는 데 유용하다

④ 방사선 노출이 없다

⑤ 임산부에게 안전하다

9. 위암으로 위원위부절제술을 받은 환자이다. 다음은 무엇인가? (바로밖에 우윳빛액체 사진)




<- 이런 색깔

① 췌장액유출

② 유미성 복수

③ 장내용물

④ 혈액

⑤ 농양

10. 50 대 남성이 산에 갔다가 뱀에 물렸다. 손등에 부종과 홍반이 있었으며, 활력징후는 안정적이었고 소변은 하루에 70ml 내외 나왔다. 사진은 다음과 같을 때 적절한 치료는? (손에 물린 자국 두개 보이는 사진, 답 논란, 아마 1 번일 듯?)



① 소독 후 경과관찰

② 근막 절개술

③ 얼음찜질

④ 강하게 압박

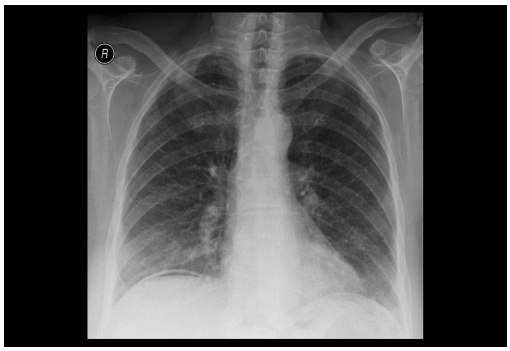
⑤ 항뱀독주사제

11. (Y) 평소 고혈압이 있던 76 세의 남자환자가 내원 한 시간 전 갑자기 발생한 back pain, abdominal pain 으로 응급실을 방문하였다. 신체검사상 복부 중앙에서 종물이 만져졌으며 혈압은 80/50mmHg 이었다. CT 소견이 다음과 같을 때 가장 가능성 있는 질환은?



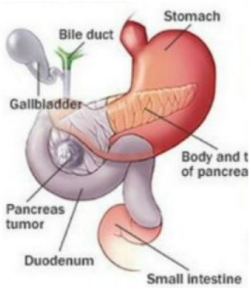
① aortic aneurysm
② mesenteric infarction
③ sigmoid volvulus
④ colon cancer obstruction
⑤ ischemic colitis

12. (Y) 42 세 남성 3 개월 전부터 공복 시 상복부 통증이 있었으나, 제산제 먹으면 호전되어 치료 없이 지내고 있었다. 금일 2 시간 전 갑자기 발생한 심한 복부 통증으로 응급실 입원. 혈압 140/80, 호흡수 95, 체온 37.7 도이다. 복부 진찰 시 복부 강직, 심한 압통과 반발압통이 있었다. 다음 중 가장 적절한 것은?



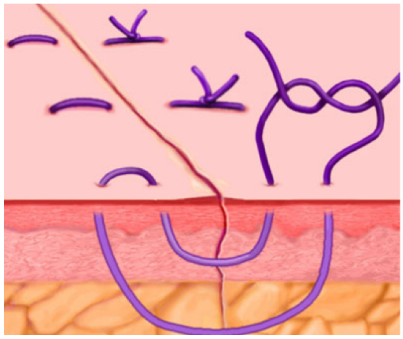
① 상부 위내시경을 시행한다.
② 소화성 궤양에 의한 위 또는 십이지장 천공이 가장 의심된다.
③ X ray 소견은 정상이다.
④ 장마비이므로 금식과 수액치료 해야한다.
⑤ 응급 수술이 필요하다.

13. (Y) 다음은 바터팽대부 환자의 수술모식도이다. 적절한 수술명을 고르시오.(푸른색 부위가 절제되는 부위)



① distal pancreatectomy
② Whipple's procedure
③ hepatojejunostomy
④ pylorus preserving pancreaticoduodenectomy(pppd)
⑤ choledocojejunostomy

14. (Y) 봉합 명칭은?



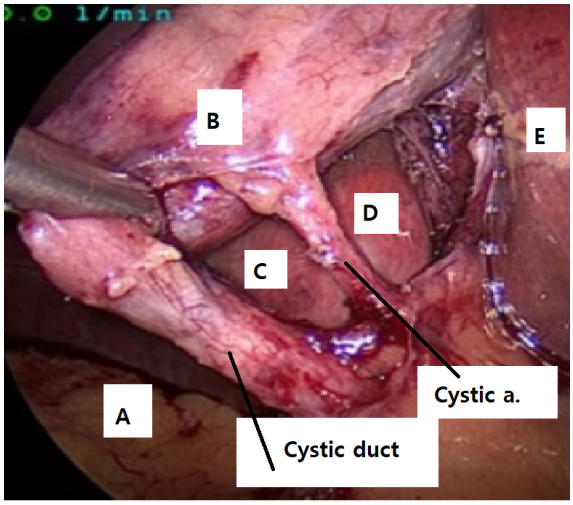
① purse string suture
② lock stitch suture
③ vertical mattress suture
④ simple interrupted suture
⑤ subcuticular running suture

15. (Y) 50 세 남자가 1 주일 전부터 하루에 10 회 이상 피가 섞인 설사로 내원하였다. 대장내시경 결과 대장 전체에 미란성 궤양이 발견되었고, 직장 점막 전체에 병변이 있었다. 3 개월 전부터 혈변과 증상악화 있었고, 10 년 전부터 약 먹고 있었으나 잘 조절되지 않았다. 치료는?

lab : WBC 155,000(중성구 87%) CEA 2.2

① 전대장절제술과 회장낭 항문 문합술
② 결장절제술과 회장 직장 문합술
③ 저위전방절제술
④ 복회음절제술
⑤ 하트만수술

16. 다음은 복강경하 담낭절제술 수술 중 사진이다. 성공적인 수술을 위한 중요한 공간이 되는 Critical View of Safety(CVS)를 다음 중 고르시오.

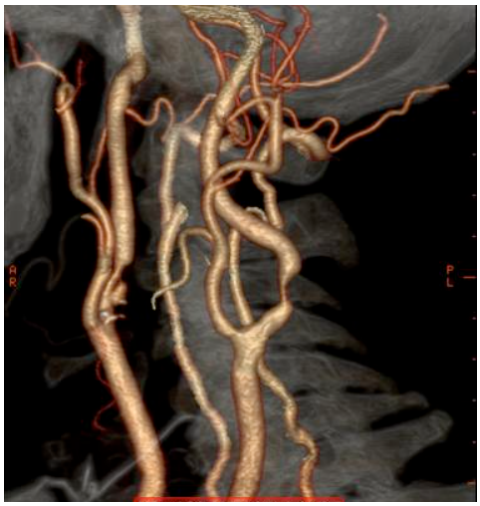


① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

17. (Y) 40 대 여성이 6 개월 전부터 변비로 인해 배변 시 통증과 출혈을 호소하며 내원하였다. 항문 주변에는 피부 늘어짐이 있었다.

① 치핵 절제술
② 내괄약근 부분 절제술
③ stool softner
④ nitroglycerin 연고

18. 73 세 여성 환자가 좌측 motor weakness 를 주소로 내원하였다. MRI 상 좌측 basal ganglia 의 뇌경색이 있었으며, CT angiography 상 사진과 같은 소견을 보였다 (아래와 유사하게 매우 좁아진 사진이었고, 아예 막히진 않았습니다). 이 환자에서 재발 방지를 위하여 가장 적절한 치료는 무엇인가?

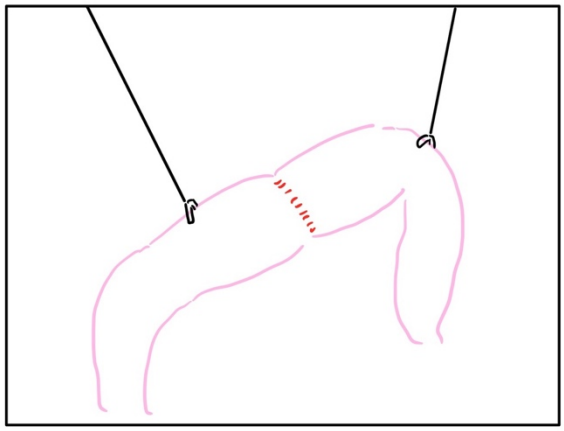


① aspirin
② clopidogrel
③ warfarin
④ 좌측 내경동맥 stent
⑤ 내막절제수술

19. 35 세 남자가 교통사고 후 발생한 복통으로 응급실에 왔다. 소장 및 대장의 광범위한 파열로 인하여 응급 개복술을 시행하였다. 수술 후 7 일째 병실을 걷던 중 아래 사진과 같은 일이 발생하였다 (장이 많이 빠져 나온 사진). 다음 중 가장 적절한 처치는?

① 병실에서 피부 봉합을 시행한다.
② 원인을 찾기 위해 복부 CT 를 촬영한다.
③ 젖은 거즈로 장을 덮은 후 수술실로 이동한다.
④ 발견 즉시 장을 집어 넣은 후 복대로 압박한다.

20. internal hernia 문제, 배꼽으로 통증을 느껴서 도수 정복을 시도 했지만 환원되지 않았고, 수술을 위해 마취를 했더니 환원되었다. 당시의 복강경 사진이다(herniation 부분에 살짝 허혈된것 같은 빨간 자국..아무리 찾아도 안나와서 그림으로 대체합니다. 정상으로 본 사람도, 비정상으로 본 사람도 있었습니다). 다음으로 해야 할 처치는?



① 경과관찰
② 소장절제
③ 폐복 후 재수술
④ 소장부분절제

21. 항문의 가려움증과 덩이가 만져져 온 환자이다. 소견이 아래 사진과 같다. 치료는?



① 항생제
② 항바이러스제
③ 항진균제
④ 수술적 절제

22. (Y) 교통사고 후 CT 에서 비장 파열이 확인되었다(문제에 실제로 '비장 파열' 언급됨). 주변 장기나 혈관 외 유출이 없는 것으로 확인되었다. 압통이 있었다. (반발압통 유무에 대한 언급은 없음) V/S 110/70, Hb 11.5 등 normal 소견 주어짐. 사진은 아래와 유사했습니다. 치료는?



① 비장부분절제
② 비장전체절제
③ 동맥색전술
④ 경과관찰

23. 3 도 화상으로 내원하였다. 사진은 아래와 같다 (사진 거의 유사함). 처치는?



① 스트렙토키나아제
② 스테로이드
③ 헤파린
④ 괴사딱지절개술

24. 다음 위암은 어떤 type 인가?

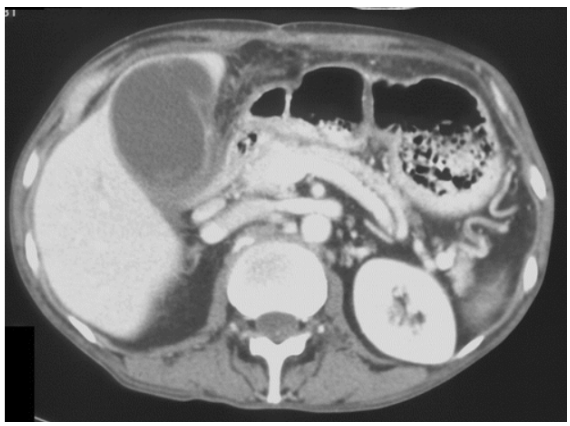
(실제 수술 후에 떼어낸 부위 전체적인 모습을 찍은 사진. 전체 위+omentum+spleen 까지 떼어냄

참고: 위의 겉면만 보고 Borrmann type 고르라고 출제되서 당황했지만 답은 type IV 맞는 것 같습니다. lesser curvature 부위에 뭔가 안쪽으로 궤양이 있을것 같은 함몰부가 있지만 그래도 답은 type IV 인듯 합니다..

① Borrmann type I
② Borrmann type II
③ Borrmann type III
④ Borrmann type IV

25. (Y) Right upper quadrant pain 및 tenderness 를 주소로 내원한 환자의 CT 이다 (아래와 같이 GB 커져 있는 등의 소견). 진단은?

WBC: 15000, Hb: 14.7, segment: 87%, total bilirubin:1.1, AST: 62, ALT: 74, CRP: 4.2



① Acute cholangitis
② Acute cholecystitis
③ Acute pancreatitis
④ Acute appendicitis

⑤ Acute hepatitis